

Vicios de Refracción (Ametropías)

Los vicios de refracción constituyen la causa predominante y estadísticamente más normal y globalizada de pérdida funcional y déficit moderado general de una adecuada acomodación y agudeza visual pura sin sustrato orgánico tisular patológico o degenerativo grave intrínseco.

- **Diferenciador Fisiopatológico General Principal:** El factor y señal semiológica diagnóstica cardinal es la **Disminución visual paulatina crónica**, y el mejoramiento temporal transitorio general cuando la visión es cribada o enfocada puramente de a través y por medio del **Agujero Estenopeico**. (El paso de la luz concentrada lineal por tal pequeño orificio minimiza drásticamente toda desviación general anómala periférica corneal provocando y favoreciendo la nitidez general del fondo de la fovea visualmente normal o estable y el consiguiente mejoramiento del campo focal óptico en los pacientes afectados).
- **Diagnóstico General:** Realizado por el oftalmólogo utilizando refracción clínica base puramente y el tamizaje regular clásico (ej: Auto-Refractometría Computarizada) o mediante prueba manual en la consulta general con cristales o la Optometría y la Carta Clásica Estándar Diagnóstica Alfabética del protocolo médico (Tabla Alfanumérica de *Snellen*), probando los poderes dióptricos del paciente en sala oscura para ver letreros).

(Nota: En física óptica, una correcta y milimétrica convergencia central pura ocular base se cataloga anatómicamente general en oftalmología como el fenotipo biológicamente y refractivamente sano sano, general e intrínsecamente llamado como el normal sujeto con ojo del rango de convergencia general "Emétrope").

Diagnóstico Diferencial de Ametropías

La alteración longitudinal o morfológica de los medios convergentes ocasiona las 4 de grandes ametropías clásicas de uso global.

TABLA 5.13.1: TIPO DE VICIO Y CONDICIONANTE VS CAUSA Y FISIOPATOLOGÍA OCULAR BIOLÓGICA		
TIPO DE VICIO Y CONDICIONANTE	CAUSA Y FISIOPATOLOGÍA OCULAR BIOLÓGICA	LENTE CORRECTOR BIOLÓGICO (CRISTALES/TOPOLOGÍA TERAPÉUTICA GENERAL)
Miopía (<i>Maso visión disminuida precaria de foco a gran distancia y gran lejanía normal</i>).	Invariable y directamente proporcionado porque el sujeto presenta longitudinalmente un globo Ocular demasiado y anormalmente grande o de gran tamaño intrínsecamente general (diámetro y polo anterior/posterior largo patológico). Condiciona y desencadena obligatoriamente que toda luz de refracción general resulte colapsada y decante en su enfoque final en el humor convergente antes y biológicamente por Delante de la Retina propiamente visual .	Resulta remediado y manejado focalmente sólo por cristales clásicos ópticos cóncavos con refracción expansiva dispersa, conocidos de la generalidad universal en receta diaria como: Lente Bicóncavo , de prescripción biótica (Graduación negativa ej -2.5D).
Hipermetropía (<i>Visión borrosa precaria de gran cercanía y de muy corto y focalizado rango normalizado</i>).	Es lo estructural u opuesto morfológicamente general al anterior, estando el sujeto constituido de base por un globo Ocular exageradamente atrófico y enano en diámetro y pequeño normal . Condicionando ineludiblemente la focalidad posterior al cruce natural ocular del fondo proyectándola en falso por la porción posterior y focalizada y proyectada netamente por detrás del telón del tejido per sé y detrás de la retina delgada natural . (Predispone fuertemente riesgo anatómico al Glaucoma agudo base futuro de cámara estrecha).	La compensación natural oftalmológica reestructurable funcional globalmente universaliza sólo la convergencia forzada temprana del reflejo visual mediante los y muy utilizados históricamente cristales clásicos positivos formales y muy curvados para aumentar el poder conocido propiamente con nombre formal: Lente Biconvexo .
Astigmatismo (<i>Borroso de cerca como idéntico problema focal de lejos e intermedio en todas las distancias estáticas cruzadas</i>).	Condicionado estructural y asimétricamente general no por longitudes globulares intrínsecas, sino por anormales y distintas desproporciones en la topología anatómica en diferentes polos y ejes base y curvaturas diferentes de refracción asimétrica de la propia cápsula de la lente original de exterior	Corrección óptica técnica especializada para anular aberraciones lineales fijas puras a través de los lentes y potentes formulaciones ópticas universales y focalizadas directrices llamados universal y masivamente prescritos hoy como los: Lentes Cilíndricos bióticos rotulados con compensaciones precisas del eje y vector irregular de

TIPO DE VICIO Y CONDICIONANTE	CAUSA Y FISIOPATOLOGÍA OCULAR BIOLÓGICA	LENTE CORRECTOR BIOLÓGICO (CRISTALES/TOPOLOGÍA TERAPÉUTICA GENERAL)
	base ocular de recubrimiento normal general de protección exterior (Córnea alterada o cristalino oval de curvatura doble anómala).	los meridianos alterados nativos del sujeto.

| **Presbicia** (*Borroso de cercana longitud progresiva general por causa única del avance de longevidad cronológica*). | Causa unívoca estructural patológica general inevitable ligada biológicamente exclusivamente a ancianidad, uso extremo global y el envejecimiento ocular y endógeno directo global degenerativo que calcifica y arruina globalmente el elástico motor nativo base endógeno estriado que pierde progresividad elásticamente y **esclerótica del cristalino progresivamente estirada** (impidiéndole re-ajustarse anatómicamente general con bombeo contráctil endógeno para acortar el rango necesario visual de gran proximidad focal). | Resuelto con alivio universal progresivo primario sencillo en corrección base para visión temporal fina mediante anteojos puramente convexos de aumento transitorio focal conocidos como los clásicos: **Lentes Biconvexos temporales de descanso general de media lectura y lentes bifocales universales inferiores para cercanía base**. |

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:
"Un trabajador de construcción llega a urgencias con salpicadura de cemento en el ojo derecho hace diez minutos. El ojo está muy irritado y cerrado. ¿Cuál es la primera acción que debe realizar el médico de urgencias?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:
Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para traumatismo ocular. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- En traumatismo ocular, el ABCD tiene prioridad antes de evaluar el ojo; luego buscar signos de gravedad: hipotonía, discoria, disminución visual, hifema y laceraciones.
- La hemorragia subconjuntival es el hallazgo más frecuente y generalmente benigno, se resuelve en dos semanas sin tratamiento.
- El hifema se maneja con posición semi-sentada, control tonométrico y corticoides tópicos; vigilar alza de presión intraocular.
- En herida penetrante ocular la conducta es no tocar el ojo, no retirar cuerpos extraños, cubrir sin presión y derivar urgente con antibióticos intravenosos.
- La quemadura química ocular es la verdadera emergencia: irrigar de inmediato con agua o suero fisiológico con ojo abierto por veinte a treinta minutos sin demora.
- Las laceraciones palpebrales se derivan al oftalmólogo si son transfixiantes, comprometen el borde libre del párpado o involucran la vía lagrimal.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (TRAUMATISMO OCULAR)

PREGUNTA 1

Un trabajador de construcción llega a urgencias con salpicadura de cemento en el ojo derecho hace diez minutos. El ojo está muy irritado y cerrado. ¿Cuál es la primera acción que debe realizar el médico de urgencias?

- A)** Realizar una anamnesis completa del accidente antes de iniciar el tratamiento
- B)** Medir el pH ocular con tiras reactivas antes de irrigar
- C)** Irrigar el ojo de inmediato con agua o suero fisiológico con el ojo abierto por veinte a treinta minutos
- D)** Aplicar colirio anestésico y derivar al oftalmólogo para evaluación
- E)** Cubrir el ojo con un parche ocular y derivar de urgencia

PREGUNTA 2

Un paciente de treinta años es atendido tras un golpe en el ojo con una pelota de tenis. Al examen se observa una colección de sangre en la cámara anterior entre el iris y la córnea, con nivel líquido visible. La agudeza visual está levemente disminuida. ¿Cuál es el diagnóstico y el manejo inicial?

- A)** Hemorragia subconjuntival; observación y control en una semana
- B)** Hifema; posición semi-sentada, tonometría de control y corticoides tópicos
- C)** Herida penetrante ocular; cubrir el ojo y derivar urgente
- D)** Uveítis traumática; corticoides tópicos y midriáticos
- E)** Glaucoma postraumático; timolol y acetazolamida de urgencia

PREGUNTA 3

Un paciente llega a urgencias con una varilla metálica incrustada en el ojo izquierdo que penetra el globo ocular. ¿Cuál es la conducta correcta?

- A)** Retirar la varilla con cuidado y cubrir el ojo con un parche
- B)** Irrigar el ojo con suero fisiológico abundante para limpiar la herida
- C)** No tocar el ojo, no retirar la varilla, cubrir sin presionar y derivar urgente con antibióticos intravenosos
- D)** Aplicar presión local para controlar el sangrado y derivar
- E)** Iniciar antibióticos tópicos y esperar evaluación de oftalmología ambulatoria

RESUMEN: TRAUMATISMO OCULAR

El traumatismo ocular es una causa frecuente de consulta en urgencias y requiere un enfrentamiento sistematizado para no perder lesiones graves. Lo primero en cualquier traumatismo es el ABCD: asegurar la vía aérea, respiración, circulación y discapacidad, antes de enfocarse en el ojo. Los signos de gravedad del traumatismo ocular que obligan a derivación urgente al oftalmólogo son: hipotonía ocular, discoria, disminución de la agudeza visual, hifema y laceraciones que comprometen el globo ocular. La hemorragia subconjuntival es el hallazgo más frecuente y generalmente benigno. Habitualmente se produce por un traumatismo menor o esfuerzo y se resuelve en dos semanas sin tratamiento. El hifema es la hemorragia en la cámara anterior entre el iris y la córnea. Se maneja con posición semi-sentada, tonometría de control y corticoides tópicos. La herida penetrante ocular es la emergencia más grave. La conducta es no tocar el ojo, no retirar el cuerpo extraño si está incrustado, cubrir el ojo sin presionarlo y derivar de urgencia con antibióticos profilácticos intravenosos, habitualmente vancomicina más ceftazidima. La quemadura química ocular es la verdadera emergencia: la irrigación copiosa es el tratamiento inmediato y la anamnesis puede esperar. Se irriga con agua o suero fisiológico con el ojo abierto durante veinte a treinta minutos. Las laceraciones palpebrales deben derivarse al oftalmólogo si son transfixiantes, comprometen el borde libre del párpado o involucran la vía lagrimal.